Saúde na Última Semana — Revista Eletrônica VIA

Edição de 25 de outubro de 2026
Semana de 18 a 24 de outubro de 2026
Curadoria médico-científica · saúde pública, cuidado, ciência e tecnologia

Capacidade instalada importa. Nesta semana, porém, a medida mais honesta foi outra: o que de fato chegou ao território, ao serviço e à consulta — e com quais limites.

Em 90 segundos

- O Amazonas atravessa seca, fumaça e dificuldade de acesso. A Força Nacional do SUS iniciou uma base em Manaus em 20/10 e outra em Porto Velho em 22/10; no dia 23, o Ministério da Saúde publicou orientações para a população e para a notificação de intoxicação por fumaça. Estrutura de resposta não significa controle do incêndio nem proteção uniforme.
- O Farmácia Popular informou presença em 5 mil municípios, onde vive 97,1% da população, e 25,3 milhões de pessoas atendidas entre janeiro e setembro de 2026. Cobertura municipal e dispensação são avanços mensuráveis; não demonstram, sozinhas, continuidade do tratamento ou controle das doenças.
- A Anvisa proibiu tiras de glicemia Accu-Chek Active identificadas como falsificadas em dois anúncios da Amazon. Ausência da embalagem externa original e a frase em inglês “ONLY FOR GOVERNMENT TENDER” são sinais descritos no alerta.
- Um estudo qualitativo publicado em 19/10 ouviu 20 pacientes expostos a escribas de inteligência artificial em consultas ambulatoriais. Eles relataram menos distrações e mais tempo para perguntas. A amostra pequena e o desenho qualitativo não autorizam concluir que a tecnologia melhora segurança, diagnóstico ou desfechos.

1. Saúde e clima — A fumaça chegou antes da adaptação

O que mudou

A base regional da Força Nacional do Sistema Único de Saúde (FN-SUS) em Manaus começou a operar em 20 de outubro para apoiar a resposta às queimadas no Amazonas. Um painel interno passou a reunir informações sobre insumos e rotas de transporte; 43 municípios haviam preenchido o sistema na data da comunicação. Em 22 de outubro, Porto Velho recebeu a quinta base regional em funcionamento no país, com cobertura planejada para a Amazônia Ocidental.

No dia 23, o Ministério da Saúde publicou orientações à população exposta à fumaça e reforçou aos profissionais o registro de intoxicações no Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan). O alerta ocorreu no contexto de estiagem severa, baixa dos rios e fumaça densa no Amazonas.

Por que importa

Queimada não é apenas evento ambiental. Material particulado fino, gases tóxicos, calor, água insegura e interrupções de transporte pressionam ao mesmo tempo a vigilância, a atenção primária, a urgência e a logística de medicamentos. Crianças pequenas, idosos, gestantes e pessoas com doenças cardíacas ou respiratórias têm maior vulnerabilidade à fumaça.

Consequência prática

Para a população em áreas afetadas: acompanhar qualidade do ar e alertas oficiais; reduzir exposição e esforço ao ar livre; manter portas e janelas fechadas quando houver fumaça; e, em saídas necessárias, preferir máscara PFF2, N95 ou P100 bem ajustada. Falta de ar, dor no peito, cansaço extremo, tosse forte ou tontura exigem avaliação; emergência é pelo SAMU 192.

Para equipes de saúde: considerar exposição recente a fumaça diante de sintomas respiratórios, cardiovasculares ou neurológicos e seguir a orientação de notificação de intoxicação exógena no Sinan. A edição não reproduz protocolo terapêutico: manejo depende de gravidade, contexto clínico e orientação técnica vigente.

Até onde a evidência permite concluir

As bases, o painel e as orientações documentam mobilização e capacidade de coordenação. Não demonstram redução de exposição, suficiência de insumos ou melhora de desfechos. O número de 43 municípios descreve adesão ao painel em 20/10, não cobertura integral do Amazonas. A probabilidade climática divulgada para um El Niño muito forte é uma projeção oficial sujeita a atualização, não um desfecho já ocorrido.

Fontes primárias e oficiais: Ministério da Saúde — base da FN-SUS em Manaus, 20/10/2026; Ministério da Saúde — base da FN-SUS em Porto Velho, 22/10/2026; Ministério da Saúde — proteção contra a fumaça e portas de atendimento, 23/10/2026; Ministério da Saúde — identificação e notificação de intoxicação por fumaça, 23/10/2026.

2. Acesso a medicamentos — Presença não é continuidade

O que mudou

Em balanço publicado em 23 de outubro, o Ministério da Saúde informou que o Programa Farmácia Popular do Brasil alcançou 5 mil municípios em 2026, onde reside 97,1% da população brasileira. O programa registrou 25,3 milhões de pessoas atendidas entre janeiro e setembro de 2026; em todo o ano de 2025, foram 27,3 milhões. A lista atual reúne 41 medicamentos e insumos oferecidos gratuitamente.

Por que importa

A capilaridade reduz uma barreira concreta: a distância entre a prescrição e a retirada. Para condições crônicas, porém, acesso não é um evento único. Depende de disponibilidade regular, prescrição adequada, compreensão do tratamento, acompanhamento e capacidade de retornar ao cuidado quando algo muda.

Consequência prática

Usuários podem verificar os itens cobertos e localizar estabelecimentos credenciados nos canais oficiais do programa. Equipes devem confirmar o que foi efetivamente retirado, revisar uso e efeitos adversos e evitar presumir adesão apenas porque o município possui uma farmácia participante.

Até onde a evidência permite concluir

Os dados foram divulgados pelo gestor federal do programa e descrevem municípios cobertos e pessoas atendidas. Não são, nesta publicação, uma avaliação independente de disponibilidade por produto, regularidade de dispensação, adesão, equidade intramunicipal ou controle clínico. O total de 2026 é parcial até setembro e não deve ser comparado como ano completo com 2025.

Fonte oficial: Ministério da Saúde — Farmácia Popular em 5 mil municípios; dados nacionais de 2025 e janeiro a setembro de 2026, publicado em 23/10/2026.

3. Segurança sanitária — Um alerta que cabe antes do teste

O que mudou

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) publicou em 22 de outubro a proibição de tiras reagentes Accu-Chek Active identificadas como falsificadas em dois anúncios da Amazon. Segundo a comunicação, os itens divergiam do produto original, não tinham a embalagem externa original e exibiam a frase em inglês “ONLY FOR GOVERNMENT TENDER”. As medidas constam das Resoluções-RE nº 4.143 e nº 4.147/2026.

Por que importa

Uma tira inadequada pode produzir leitura errada e deslocar uma decisão sobre alimentação, medicação ou busca de atendimento. O risco não é resolvido por aparência familiar da marca nem por avaliação positiva em plataforma de venda.

Consequência prática

Quem adquiriu produto com essas características ou pelos anúncios citados deve interromper o uso, preservar embalagem e comprovante e buscar orientação nos canais da Anvisa e do fabricante. Diante de sintomas ou resultado incompatível com o estado clínico, a conduta segura é confirmar a glicemia por método confiável e procurar avaliação — não ajustar insulina ou outro medicamento apenas com base em uma leitura suspeita.

Até onde a evidência permite concluir

O alerta é específico para os produtos falsificados e anúncios descritos; não autoriza generalizar suspeita a todas as tiras Accu-Chek Active. A própria página da Anvisa traz um provável erro material ao mencionar “22/11” no corpo, embora o registro de publicação e as resoluções sejam de 22/10. Esta edição usa a data oficial de publicação e remete às resoluções.

Fontes primárias: Anvisa — alerta de falsificação, publicado em 22/10/2026; Diário Oficial da União — Resolução-RE nº 4.143, de 20/10/2026; Diário Oficial da União — Resolução-RE nº 4.147, de 20/10/2026.

4. IA no cuidado — Mais presença percebida, prova ainda pequena

O que mudou

Um estudo publicado online em 19 de outubro no Journal of General Internal Medicine explorou a experiência de 20 pacientes cujos profissionais participavam de um ensaio pragmático de implementação de escriba de inteligência artificial (IA) ambiente. Nas entrevistas, pacientes relataram menos distrações, notas mais completas e mais tempo para respostas às suas perguntas. Conforto variou com familiaridade tecnológica, baixa percepção do dispositivo, ausência de preocupação com privacidade e relação prévia positiva com o profissional.

Por que importa

O escriba ambiente promete devolver atenção à conversa ao transformar áudio da consulta em rascunho de registro. A questão central não é apenas velocidade: consentimento, privacidade, revisão humana, fidelidade do prontuário e possibilidade de recusa fazem parte da qualidade do cuidado.

Consequência prática

Serviços que testem a tecnologia devem explicar seu uso antes da gravação, oferecer recusa sem prejuízo, definir retenção e acesso aos dados e exigir revisão do texto pelo profissional antes de incorporá-lo ao prontuário. A ferramenta pode preparar documentação; não deve assumir decisão clínica nem autoria automática.

Até onde a evidência permite concluir

É um estudo qualitativo, de centro acadêmico e com 20 participantes, encerrado quando os autores julgaram atingir saturação temática. Ele descreve experiências percebidas; não mede acurácia das notas, eventos adversos, qualidade diagnóstica ou desfechos. Conflitos declarados incluem participação acionária de um autor e convite de outro para conselho consultivo de uma empresa do setor. O resultado justifica implementação cautelosa e pesquisa maior, não adoção irrestrita.

Fonte primária: Nguyen e colaboradores — estudo qualitativo, *Journal of General Internal Medicine*, publicado online em 19/10/2026; PMID 42897388; DOI 10.1007/s11606-026-10931-4.

Ações práticas desta semana

- Em áreas com fumaça: reduzir exposição, acompanhar alertas locais e procurar atendimento diante de sinais de alarme; profissionais devem registrar intoxicações conforme a orientação do Sinan.
- No cuidado crônico: usar a expansão do Farmácia Popular como porta de acesso, mas conferir retirada, uso, disponibilidade e resposta clínica.
- Antes de medir glicemia: verificar embalagem, procedência e sinais do alerta da Anvisa; leitura incompatível com sintomas precisa de confirmação segura.
- Ao testar escriba de IA: consentimento, transparência, revisão humana e governança de dados vêm antes da conveniência.
- Em hospitais: a Anvisa abriu a Avaliação Nacional dos Programas de Gerenciamento de Antimicrobianos 2026 para instituições públicas, privadas, filantrópicas e militares, com preenchimento até 20/12/2026. Participar produz diagnóstico; não equivale a ter o programa implantado. Orientação e formulário, 23/10/2026.

O que a VIA leva desta semana

- Base regional é capacidade de resposta; seu valor precisa aparecer no tempo, no alcance e na continuidade do cuidado.
- Município coberto não é paciente acompanhado.
- Alerta sanitário útil termina em uma ação verificável, não em pânico de marca.
- IA pode reduzir a presença do computador na consulta e, ao mesmo tempo, introduzir nova infraestrutura de vigilância, erro e responsabilidade.

O fio da semana é a diferença entre estar disponível e funcionar com segurança. A base precisa chegar ao município isolado; o medicamento, ao tratamento contínuo; a tira, a uma medida confiável; o escriba, a um prontuário revisto. A unidade real de inovação continua sendo o circuito completo do cuidado.

Método editorial

Recorte principal: fatos publicados ou implementados entre 18 e 24/10/2026. Fontes oficiais foram abertas no registro específico; números mantêm o escopo temporal informado por cada órgão. A literatura sobre IA foi localizada por busca bibliográfica e conferida no registro original do PubMed. Estudo qualitativo foi apresentado como experiência percebida, não como eficácia. Sarampo não entrou: não houve fato material, suficientemente lastreado e comparável às pautas selecionadas nesta janela.

Material educativo. Não substitui avaliação clínica individual, protocolo assistencial, norma sanitária nem fonte epidemiológica em tempo real. Não é bula, laudo ou recomendação de produto. Conduta parte de contexto, vínculo clínico e fonte oficial vigente.

Dr Lucas HR Almeida Editorial · Médico generalista (FMRP-USP) CRM-SP 226836 · CRM-MG 109752